REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Leucemias e Linfomas

Leucemias agudas, emergências onco-hematológicas e linfomas em uma página

MAIS COBRADO

- **1º LPA**: CIVD, emergência hemorrágica
- **2º Neutropenia febril**: antibiótico já
- **3º Linfonodo suspeito** → biópsia excisional
- **4º Hodgkin × não Hodgkin**

1 Leucemia aguda: diagnosticar

falência medular + infiltração

Medula: anemia, **plaquetopenia**, neutropenia (febre). **Infiltração:** dor óssea (criança com LLA), visceromegalia, hipertrofia gengival (monocítica), massa mediastinal (LLA-T), SNC e testículo.

LMA ≥ 20% de blastos (qualquer % com t(15;17), t(8;21), inv(16)) · LLA pediátrica ≥ 25%. **Imunofenotipagem** separa LMA × LLA. Leucemia = 28% dos cânceres infantis (LLA 75–80%).

	LLA	LMA
Quem	**Criança, pico 2–5 anos**	**Adulto** (80% das agudas), mediana 67 anos
Marcadores	TdT+; B: CD19, CD10, CD22 · T: CD3, CD7	MPO, CD13, CD33, CD117 · **bastonetes de Auer**
Prognóstico	Bom: hiperdiploidia, t(12;21), **DRM negativa** · Ruim: > 50.000, hipodiploidia, **Ph+** (→ inibidor de tirosina-quinase)	ELN: favorável t(8;21), inv(16), NPM1 · adverso TP53, cariótipo complexo, −5/−7 (2022: FLT3-ITD = intermediário)
Tratar	Indução → consolidação → **profilaxia do SNC** → manutenção **6-MP + MTX** (2–2,5 anos). Criança > 85%; adulto 20–30% (HyperCVAD)	**"7 + 3"** (citarabina + antraciclina) → citarabina ou TCTH · idoso: **azacitidina**

LPA t(15;17) PML-RARA: **CIVD**, risco de hemorragia intracraniana. Risco baixo: **ATRA + trióxido de arsênio**; alto: + antraciclina. **Síndrome de diferenciação** (3 primeiras semanas) → glicocorticoide. Cura ~85%.

2 Emergências

LISE TUMORAL

Burkitt, LLA, LDH > 1.500 · 12–72 h após QT · ↑ ác. úrico, K, P · ↓ Ca · **hidratação 3 L/m²/dia** + alopurinol ou **rasburicase** (não na G6PD).

LEUCOSTASE

Blastos > 100.000 + pulmão/neuro (mais na LMA) · QT logo, **hidroxiureia** · **evite transfundir hemácias** · pseudo-hipoxemia.

NEUTROPENIA FEBRIL

≥ 38,5 °C ou 3 × ≥ 38 °C em 24 h + neutrófilos **< 500** → culturas + **cefepima/pip-tazo** sem esperar · fungos se febre 4–7 dias.

3 Linfomas

biópsia excisional · Ann Arbor / Lugano

Linfonodo suspeito: > 2 cm, indolor, **supraclavicular**, > 4–6 semanas, sintomas B, > 40 anos · US: arredondado, **sem hilo**, vasos periféricos → **biópsia excisional** (PAAF e core não bastam). Evite corticoide antes.

	Hodgkin	Não Hodgkin
Célula	**Reed-Sternberg CD30+ CD15+**, CD45−	B em ~90%
Quem	Bimodal · EBV, HIV · esclerose nodular (70–80%, mediastino)	Aumenta com a idade · HIV, EBV, HTLV-1, H. pylori
Disseminação	**Contígua**, supradiafragmática	**Não contígua**, extranodal
Tratar	**ABVD** ± RT · BEACOPP esc. (alto risco < 60) · cura ~75% (PCDT)	LDGCB: **R-CHOP** (cura 60–65%)

LNH: LDGCB 30–40% · folicular **t(14;18)** (transforma ~3%/ano) · Burkitt **t(8;14)**, "céu estrelado", lise espontânea · manto **t(11;14)** · MALT gástrico → **erradicar H. pylori**.

Ann Arbor: I uma cadeia · II ≥ 2 mesmo lado · III dois lados · IV extranodal disseminado · **B**: febre > 38 °C, sudorese, perda > 10% em 6 meses · **X** ≥ 10 cm.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Aguda × crônica:** aguda bloqueia a maturação (blastos); crônica acumula células maduras.
2. **Leucemia × linfoma:** medula × tecido linfoide; LLA e linfoma linfoblástico são a mesma doença.
3. **Imunofenotipagem** é o exame que separa LMA de LLA.
4. **Bastonete de Auer** torna a LMA praticamente certa.
5. **Sangramento + fibrinogênio baixo** na leucemia: pense em LPA.
6. **Corticoide antes do mielograma** mascara a LLA.
7. **Dor óssea + citopenias** na criança: LLA, não artrite.
8. **Rasburicase** é proibida na deficiência de G6PD.
9. **Lise tumoral é rara na LMA**; típica de Burkitt e LLA.
10. **Neutropenia febril:** sem neutrófilo não há pus; a febre pode ser o único sinal.
11. **Supraclavicular esquerdo** (Virchow) = abdome; direito = tórax.
12. **Mediastino anterior:** os 4 Ts (timoma, teratoma, tireoide, "terríveis" linfomas).
13. **Linfoma pode trazer AHAI** e plaquetopenia imune: peça provas de hemólise.
14. **Hodgkin tardio:** hipotireoidismo (~50% após RT cervical), mama, coração, bleomicina no pulmão.

Escores

IPI (1 ponto cada): idade > 60 · **LDH ↑** · ECOG ≥ 2 · estádio III–IV · > 1 extranodal → 0–1: 73% · 2: 51% · 3: 43% · 4–5: 26% (sobrevida 5 anos)

IPS (Hodgkin avançado, 7 fatores): homem, > 45 anos, estádio IV, albumina < 4, Hb < 10,5, leucócitos > 15.000, linfócitos < 600